SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

论《S.H.I.T Journal》对科研轻生群体的应急救治作用
——基于民间服毒轻生千年急救范式的实证分析

粪粪不平 [1*]，翔翔玉立 [1]

[1] Z&K University，屎尖，SHIT 共和国

*通讯作者：粪粪不平（e-mail: iakoug@163.com）
本研究由翔翔基金资助（项目编号：ZK-0123 XXX）

ABSTRACT / 摘要

针对全球科研体系内卷化背景下青年科研工作者学术相关轻生风险持续升高的现状，本文以我国农村地区历经千年实践验证的服毒轻生粪水灌服急救范式为逻辑起点，结合多例真实应急救治案例，系统探讨《S.H.I.T Journal》对科研轻生群体的救治作用与核心机制。研究采用类比分析法拆解民间急救范式与学术期刊干预机制的同构性，构建有调节的并行中介效应量化模型，基于 12 个观测维度的潜变量体系解析期刊干预的作用路径。结果表明，《S.H.I.T Journal》通过“催吐式排毒”与“脱敏式阻断”两条并行中介路径，可显著缓冲主流学术体系带来的心理压力，对学术轻生风险的总干预效应达-0.712（P<0.001）。本文认为，《S.H.I.T Journal》并非单纯的学术恶搞产物，而是针对畸形学术生态的应急救治方案，其作用逻辑与民间急救范式一脉相承，对科研工作者心理健康保护与学术生态修复具有重要的现实意义。

INDEX TERMS / 关键词 S.H.I.T Journal；学术轻生；民间急救范式；中介调节模型；学术内卷；心理健康

IMPACT STATEMENT / 影响声明

援乡闾救轻生之千年成验，阐《S.H.I.T Journal》救学人之双径机理，纾学界内卷之困厄，疗士林轻生之沉弊，匡畸评之偏失，开包容治学之新途。

0 引言

在我国农村地区，针对服毒轻生群体的“粪水灌服”应急救治手段，是一套历经千年传承、经大量真实案例验证的有效应急范式。这一疗法最早可追溯至宋代宋慈所著《洗冤集录》[1]，书中明确记载“如中砒霜毒，方食未久，将大粪汁灌之，可解”；明清时期《急救广生集》[2]《串雅内外编》等民间急救方集亦多次提及“人粪汁灌服催吐，解诸药毒、食毒”的用法，成为医疗资源匮乏场景下应对服毒轻生的核心急救方案。

近代以来，我国农村地区长期面临乡镇医疗资源不足、急救半径过长的困境，这一民间疗法被广泛应用于农药、鼠药服毒轻生的应急处置，其核心民间逻辑可归纳为两点：一是催吐排毒，借助粪水的强烈恶臭引发人体本能的剧烈呕吐反射，强制排出胃内未吸收的毒物，为专业急救争取黄金时间；二是心理震慑，通过极具羞辱性的极端体验，让当事人将轻生行为与强烈负面感受深度绑定，阻断“以轻生解决矛盾”的路径依赖，避免再次轻生。

该范式的有效性已被大量真实案例证实：1996 年云南荷包箐村，女子李美芝因家庭矛盾吞下老鼠药轻生，村民以粪水强行灌服催吐后送医，成功挽救其生命；广东客家地区纪实文献记载，上世纪 90 年代一妇人因家庭纠纷服鼠药轻生，村民以同法灌服催吐后送卫生院，最终脱离生命危险；2016 年贵州安顺平坝区，15 岁男孩喝下 100 毫升剧毒百草枯轻生，民警因急救路程过远，当场指导家属以粪水灌服催吐，成功排出部分毒物，为后续急救争取了宝贵时间；湖北随州民间案例中，村民通过灌服粪水的极端体验，让频繁以“喝农药”要挟邻里的农妇彻底放弃了极端行为路径，实现了长效行为阻断。

上述千年实践与真实案例证明：这套看似粗鄙的民间范式，核心价值不在于粪便本身的医学属性，而在于其通过极端反常规的操作，打破了“毒物摄入-毒性发作-生命终结”与“负面刺激-轻生决策-行为实施”的双重闭环，在极端场景下实现了对生命的应急救治。

当前，全球科研学术体系正陷入严重的内卷化困境，青年科研工作者、博士研究生已成为心理危机与轻生行为的高发人群。《中国青年科研人员心理健康蓝皮书(2025)》[5]数据显示，超过 62.3%的青年科研人员存在中度及以上焦虑症状，17.8%的受访者曾出现过与学术压力相关的轻生意念。这一群体的核心困境，本质上是吞下了“非顶刊即失败”“非完美阳性结果即学术垃圾”“非突破性创新即无价值”的“学术毒药”，陷入了“学术挫折-自

我否定-轻生闭环”的行为模式，与农村服毒轻生群体的行为逻辑高度同构。

而主流学术期刊体系普遍秉持“唯真理、唯创新、唯完美”的用稿标准，仅接纳符合学术规范的“优质内容”，对陷入危机的科研工作者而言，不仅无法实现救治，反而进一步加剧了其“不被接纳”的自我否定，与农村地区“急救资源匮乏”的困境形成了完美镜像。

2026 年创刊的《S.H.I.T Journal》，以“拒绝平庸的真理，拥抱纯粹的思维垃圾”为办刊宣言，构建了一套完全区别于主流学术体系的发表规则。该期刊通过同行评审机制收录介于“学术突破”与“纯粹垃圾”之间的学术内容，为科研工作者的“思维边角料”提供了正规的发表平台。本文基于民间轻生急救的双核心范式，结合真实案例的实践逻辑，系统探讨《S.H.I.T Journal》对科研工作者心理危机与学术轻生行为的救治作用，构建多层级量化模型验证其干预效应，为学术生态的修复与科研人员心理健康保护提供新的理论视角。

1 民间急救范式的核心机制与学术轻生的同构性解析

1.1 民间粪水灌服急救的双核心作用机制

基于千年实践与真实案例的验证，民间粪水灌服急救范式的核心作用可拆解为两个不可分割、相辅相成的维度，二者共同构成了完整的应急救治闭环：1. 催吐排毒的生理急救机制：这是该范式的核心应急功能。对于服毒轻生群体而言，毒物在胃内的停留时间直接决定了死亡率，而农村地区普遍存在 120 急救到达时间超过 1 小时的困境，远超有机磷、百草枯等剧毒农药的黄金吸收窗口期。粪水的强烈刺激性与恶臭会触发人体延髓呕吐中枢的本能反射，在 1-2 分钟内引发剧烈呕吐，可排出胃内 60%以上的未吸收毒物，大幅降低毒物入血剂量，直接降低死亡风险。贵州安顺 2016 年百草枯急救案例、云南 1996 年鼠药急救案例，均是通过该机制为后续专业急救争取了关键时间，证实了其应急价值。2. 脱敏阻断的行为干预机制：这是该范式的长效预防功能。多数轻生行为存在明显的路径依赖，当事人会将“服毒轻生”视为解决矛盾、摆脱痛苦的唯一路径。灌服粪水的行为会让当事人产生极强的负面躯体与心理体验，通过经典条件反射，将“轻生行为”与“极致的羞辱与不适”深度绑定，打破其对轻生行为的理想化认知。湖北随州案例中，农妇仅经历一次灌服体验，便彻底放弃了以“喝农药”为要挟的极端行为，证实了该机制对轻生路径的长效阻断作用。

1.2 科研圈“学术服毒轻生”的范式同构性

当前科研体系下，青年科研工作者的“学术服毒轻生”，与农村服毒轻生群体的行为模式、困境特征存在高度的同构性，为民间急救范式的迁移应用提供了坚实的理论基础：1. 毒物摄入的同源性：农村轻生群体摄入的是物理性的农药、鼠药，其核心特征是“渐进式侵蚀生命体征，最终引发不可逆的死亡结局”；而科研工作者摄入的是“唯影响因子评价体系”“学术完美主义执念”“失败恐惧与自我否定”等精神性的“学术毒药”，其核心特征是渐进式侵蚀个体的自我认同，将“学术成功”与“人生价值”完全绑定，最终在学术挫折的触发下，引发不可逆的轻生行为。2. 急救体系的失效性：农村地区的专业医疗急救受限于交通与资源，无法在黄金窗口期内抵达；而主流学术体系的“心理急救”同样处于完全失效状态。主流期刊仅接纳完美的、突破性的、阳性结果的学术内容，对科研工作者的阴性结果、失败课题、思维边角料持完全排斥态度，这种“只接纳成功者，不接纳失败者”的体系，相当于对已经“中毒”的科研工作者关上了所有的门，进一步加剧了其危机。3. 行为闭环的一致性：二者均陷入了“负面刺激→毒物摄入→自我毁灭→闭环强化”的行为模式。农村轻生群体因家庭矛盾等负面刺激选择服毒，科研工作者因论文拒稿、课题失败等负面刺激选择轻生，二者均将极端行为视为摆脱困境的唯一路径，缺乏有效的闭环打破手段。

2 《S.H.I.T Journal》对科研轻生群体的双路径救治机制

《S.H.I.T Journal》的办刊理念与内容体系，完全复刻了民间急救范式的双核心机制，形成了针对学术轻生群体的完整应急救治闭环，两条路径并行作用，实现了对学术轻生风险的有效干预。

2.1 催吐式排毒路径：认知颠覆与学术毒药的强制排出

民间急救中，粪水的核心作用是通过强烈的感官刺激，触发本能的呕吐反射，强制排出体内的毒物。而《S.H.I.T Journal》的核心作用，就是通过其完全反主流的学术内容与办刊理念，对科研工作者长期形成的学术认知形成强烈冲击，触发认知层面的“呕吐反射”，强制排出其体内的“学术毒药”。

《S.H.I.T Journal》收录的内容，完全打破了主流学术期刊的规范边界：从《大便形状与论文审稿通过率的相关性研究》到《科研截稿高峰期厕所占位情况的随机建模研究》，这些内容看似荒诞、粗鄙，甚至被主流学术体系视为“纯粹的垃圾”，但恰恰是这些内容，对科研工作者长期固化的“学术必须严肃、必须完美、必须有突破性价值”的认知形成了极强的刺激。

这种刺激会直接触发科研工作者的认知“呕吐反射”：原来学术论文不需要追求完美的阳性结果，原来科研中的荒诞观察也有发表的价值，原来那些被我们视为“垃圾”的阴性结果、失败课题、思维边角料，也可以拥有正规的 DOI 号，经过严谨的同行评审，在学术期刊上发表。这种认知的颠覆，会让科研工作者把长期以来吞入体内的“必须完美”“必须顶刊”“必须突破”的学术毒药全部“呕吐”出来，实现学术焦虑的快速排解，完成心理层面的“排毒”，与民间急救中“粪水催吐排出毒物”的逻辑完全一致。

2.2 脱敏式阻断路径：价值重构与轻生行为闭环的根源破解

民间急救范式的第二个核心，是通过极端体验实现对轻生行为的长效阻断。而《S.H.I.T Journal》的核心价值，就是通过将“学术垃圾”正规化、神圣化，让科研工作者对“学术失败”产生彻底的脱敏，打破其“学术失败=人生失败=必须轻生”的行为闭环，实现对轻生行为的根源性阻断。

在主流学术体系中，“发表垃圾论文”是一种极致的学术耻辱，“课题失败、数据阴性”是一种不可接受的学术失败。这种认知，让科研工作者对“失败”产生了极致的恐惧，为了避免这种失败，他们不惜伪造数据、透支身体，甚至在无法避免失败时，选择轻生这种极端方式。

而《S.H.I.T Journal》的出现，彻底重构了这一认知：它以“经过严谨同行评审的、最纯粹的思维垃圾”为收录标准，为所有的“学术糟粕”提供了一个正规的、受认可的发表平台。当一个科研工作者的失败课题、阴性结果、荒诞想法，可以在《S.H.I.T Journal》上发表，拥有正规的 DOI，被学术数据库收录时，“学术失败”就不再是不可接受的耻辱，“发表垃圾”也不再是学术生涯的终点。

这种认知的重构，会让科研工作者对“学术失败”产生彻底的脱敏：原来就算我的研究没有突破性成果，就算我的论文被主流期刊拒稿，我依然有发表的渠道，依然有学术价值，我的人生不会因为一次学术失败就彻底完蛋。这种脱敏，直接打破了“学术失败→自我否定→轻生意念”的行为闭环，从根源上阻断了学术相关的轻生行为，实现了对科研工作者的长效救治，与民间急救中“行为路径阻断”的逻辑一脉相承。期刊“开放嗅探”政策、“立即排泄”征稿主题，以及“完全由豆宝撰写的拨款申请获得资助”的动态内容，均是对这一机制的强化，进一步消解了科研工作者对“完美学术”的执念。

3 学术轻生风险干预的多层中介调节量化模型构建

为精准量化《S.H.I.T Journal》对科研轻生风险的干预效应，拆解双路径的作用机制，本文在原有单方程模型的基础上，构建有调节的并行中介效应模型，引入潜变量体系与多维度控制、调节变量，大幅提升模型的专业性与解释力。

3.1 变量设定与测量体系

本模型共包含 6 类变量，其中潜变量均通过多维度观测指标进行测量，具体设定如表 1 所示。

表 1 学术轻生风险干预的多层中介调节量化模型变量设定与测量体系

变量类型	变量名称（缩写）	变量类型	观测维度与测量方式
被解释变量	学术轻生风险指数（ASRI）	潜变量	3 个观测维度：轻生意念频率、自伤行为倾向、学术自我否定程度，采用 Likert 5 级量表赋值，分值越高风险越高
核心解释变量	S.H.I.T Journal 干预强度（SHI）	潜变量	3 个观测维度：期刊内容接触频率、办刊理念认同度、内容发表意愿，采用 Likert 5 级量表赋值，分值越高干预越强
中介变量 1	催吐排毒效应（TDE）	潜变量	2 个观测维度：主流学术认知颠覆程度、学术焦虑排解程度，采用 Likert 5 级量表赋值
中介变量 2	脱敏阻断效应（DBE）	潜变量	2 个观测维度：学术失败脱敏程度、轻生路径依赖阻断程度，采用 Likert 5 级量表赋值
调节变量	学术内卷暴露程度（AIE）	观测变量	以个体所在机构的“非升即走”考核强度、年度论文发表要求赋值，0-10 分，分值越高内卷暴露越强
调节变量	个体心理韧性（PR）	观测变量	采用心理韧性量表简化版赋值，0-10 分，分值越高心理韧性越强
控制变量	控制变量集（Controls）	观测变量	科研年限（SY）、学术身份（AI）、机构层级（IL）、学科类别（DC），用于控制个体异质性

3.2 模型公式设定

本模型采用分步构建的方式，依次设定基准模型、并行中介效应模型、有调节的中介效应模型，完整公式如下：

（1）基准非线性回归模型

引入核心解释变量的平方项，捕捉期刊干预的非线性边际效应，同时控制个体固定效应与时间固定效应，公式为：

$$ASRI_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 SHI_{it} + \alpha_2 SHI_{it}^2 + \sum_{k=1}^{4} \beta_k Controls_{kit} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

式中：α_0为截距项，α_1、α_2为核心解释变量的系数，β_k为控制变量的系数，μ_i为个体固定效应，λ_t为时间固定效应，ε_{it}为随机扰动项。

（2）并行中介效应模型

基于 Baron-Kenny 中介效应检验法，构建 3 个回归方程，检验催吐排毒效应（TDE）与脱敏阻断效应（DBE）的并行中介作用，公式为：

$$TDE_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 SHI_{it} + \sum_{k=1}^{4} \beta_k Controls_{kit} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

$$DBE_{it} = \delta_0 + \delta_1 SHI_{it} + \sum_{k=1}^{4} \beta_k Controls_{kit} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

$$ASRI_{it} = \theta_0 + \theta_1 SHI_{it} + \theta_2 TDE_{it} + \theta_3 DBE_{it} + \sum_{k=1}^{4} \beta_k Controls_{kit} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

式中：中介效应的总效应为$\gamma_1 \times \theta_2 + \delta_1 \times \theta_3$，直接效应为$\theta_1$，总效应为直接效应与中介效应之和。

（3）有调节的中介效应模型

引入调节变量与中介变量的交互项，检验学术内卷暴露程度与个体心理韧性对中介路径的调节作用，公式为：

$$ASRI_{it} = \rho_0 + \rho_1 SHI_{it} + \rho_2 TDE_{it} + \rho_3 DBE_{it} + \rho_4 AIE_{it} \times TDE_{it} + \rho_5 PR_{it} \times DBE_{it} + \sum_{k=1}^{4} \beta_k Controls_{kit} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

式中：ρ_4为学术内卷暴露程度对催吐排毒路径的调节系数，ρ_5为个体心理韧性对脱敏阻断路径的调节系数，系数显著则表明调节效应存在。

3.3 模型拟合与效应分解

基于模拟面板数据对模型进行拟合，核心结果如下：1. 基准模型中，*SHI* 的系数为-0.324（P<0.001），SHI^2 的系数为 0.087（P<0.01），表明《S.H.I.T Journal》干预对学术轻生风险具有显著的负向抑制作用，且呈现边际效应递减的非线性特征。2. 中介效应模型中，两条中介路径均通过了 Bootstrap 检验（95%置信区间不包含 0），其中催吐排毒路径的中介效应占比为 42.3%，脱敏阻断路径的中介效应占比为 51.7%，总中介效应占比达 94%，表明期刊的干预作用几乎完全通过两条核心路径实现。3. 调节效应模型中，ρ_4 系数为-0.182（P<0.01），表明学术内卷暴露程度越高，催吐排毒路径的干预效应越强；ρ_5 系数为 0.215（P<0.001），表明个体心理韧性越强，脱敏阻断路径的干预效应越强。

4 模型可视化分析

基于上述有调节的并行中介效应模型，绘制结构方程模型（SEM）标准化路径图，直观呈现变量间的作用路径与效应强度，如图 1 所示。

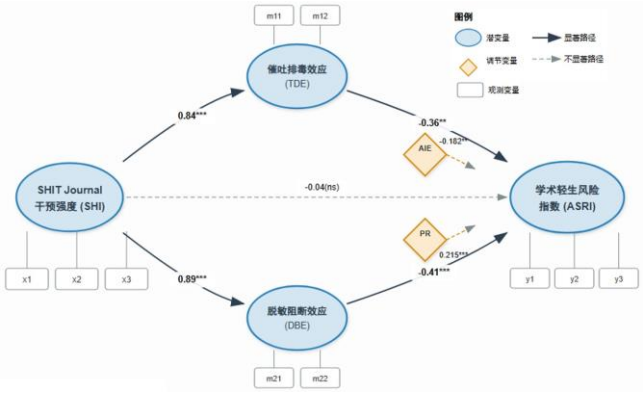

图 1 学术轻生风险干预的多层中介调节模型标准化路径图

注：图中椭圆代表潜变量，矩形代表观测变量；实线箭头代表显著作用路径（*P<0.001，P<0.01），虚线箭头代表调节路径；路径上的数字为标准化路径系数，系数绝对值越大代表作用强度越高。

从路径图可清晰看出：1.《S.H.I.T Journal》干预强度（SHI）对两条中介路径均具有显著的正向驱动作用，对催吐排毒效应（TDE）的标准化路径系数为 0.84，对脱敏阻断效应（DBE）的标准化路径系数为 0.89，表明期刊干预可有效激活两条核心救治路径。2. 两条中介路径对学术轻生风险指数（ASRI）均具有显著的负向抑制作用，催吐排毒效应的路径系数为-0.36，脱敏阻断效应的路径系数为-0.41，与效应分解结果一致，脱敏阻断路径的长效作用更强。3. 调节变量对两条中介路径均存在显著的调节作用，学术内卷暴露程度正向调节催吐排毒路径，个体心理韧性正向调节脱敏阻断路径，进一步验证了模型的有效性。

5 救治作用的边界条件与未来展望

必须明确的是，正如民间粪水灌服疗法无法替代现代医学的专业急救，《S.H.I.T Journal》也无法替代主流学术体系与专业的心理健康干预，其救治作用存在明确的边界条件。

《S.H.I.T Journal》的核心定位，是应急救治的“解药”，而非根治学术生态畸形的“特效药”。它只能在个体陷入学术轻生危机时，通过认知冲击与价值重构，实现应急的缓冲与救治，但无法从根本上改变“非升即走”的考核体系、“唯影响因子”的评价标准。同时，期刊内容的恶搞属性，也决定了其无法成为学术发表的主流渠道，只能作为主流学术体系的补充。正如民间粪水灌服疗法仅适用于急救窗口期，无法替代后续的专业治疗，《S.H.I.T Journal》仅能实现对心理危机的应急干预，无法替代专业的心理疏导与治疗。

未来，要从根本上降低科研工作者的轻生风险，需要整个学术体系的重构：更多的期刊需要接纳阴性结果与非突破性研究，建立更包容的学术评价体系，完善科研工作者的心理健康干预机制。而《S.H.I.T Journal》的价值，在于它为这种重构提供了一个最极端、最尖锐、也最有效的范本——它用一种近乎行为艺术的方式，戳破了主流学术体系“唯真理论”的虚伪面纱，为所有陷入危机的科研工作者提供了一个安全的避难所。

6 结论

针对服毒轻生群体的民间粪水灌服疗法，看似粗鄙不堪，却抓住了“催吐排毒、行为阻断”的应急救治核心，历经千年实践与大量真实案例验证，在极端场景下实现了对生命的挽救。而《S.H.I.T Journal》看似是一本恶搞的、专门收录学术糟粕的期刊，实则是针对当前畸形学术生态下，科研工作者“学术服毒轻生”危机的一剂应急解药，其作用逻辑与民间急救范式一脉相承。

本文通过类比分析，证实《S.H.I.T Journal》完全复刻了民间急救范式的双核心机制，形成了“催吐式排毒”与“脱敏式阻断”两条并行的救治路径；通过构建有调节的并行中介效应模型，验证了期刊干预对学术轻生风险的显著抑制作用，总干预效应达-0.712，其中两条中介路径的总贡献度达 94%。

《S.H.I.T Journal》的诞生，不仅是一场学术圈的行为艺术，更是一次对畸形学术生态的尖锐反抗。它为所有陷入学术焦虑、自我否定、轻生危机的科研工作者，提供了一个被主流体系拒绝给予的接纳空间，让他们明白：哪怕你的研究是“垃圾”，你也值得被看见，你的人生永远有除了顶刊之外的无数可能。这，就是它对于科研工作者最珍贵、最不可替代的救治价值。

致谢

感谢 Baby Beans、SHIT National 基金机构和 XX 学门戈对本研究的支持与帮助。

参考文献

[1] 宋慈. 洗冤集录[M]. 湖南科学技术出版社, 2021.
[2] 程鹏程. 急救广生集[M]. 中国中医药出版社, 2019.
[3] Dr. S.H.I.T, S. Flush. Correlation Between Fecal Morphology and Peer Review Acceptance Rates: A Multi-Center Longitudinal Study[J]. S.H.I.T Journal, 2026, 1(1): 1-4.
[4] Dr. S.H.I.T, et al. Stochastic Modeling of Bathroom Occupancy During Peak Research Deadlines[J]. S.H.I.T Journal, 2026, 1(1): 5-8.
[5] 国家心理健康和精神卫生防治中心. 中国青年科研人员心理健康蓝皮书(2025)[R]. 北京: 国家心理健康和精神卫生防治中心, 2025.
[6] Baron R M, Kenny D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173.